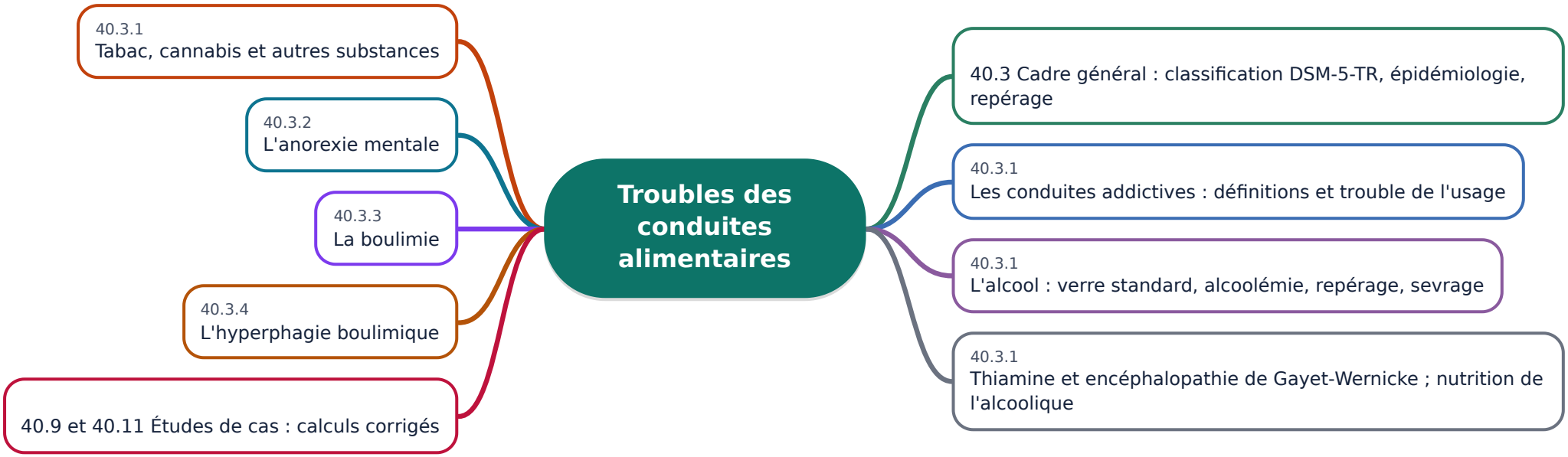
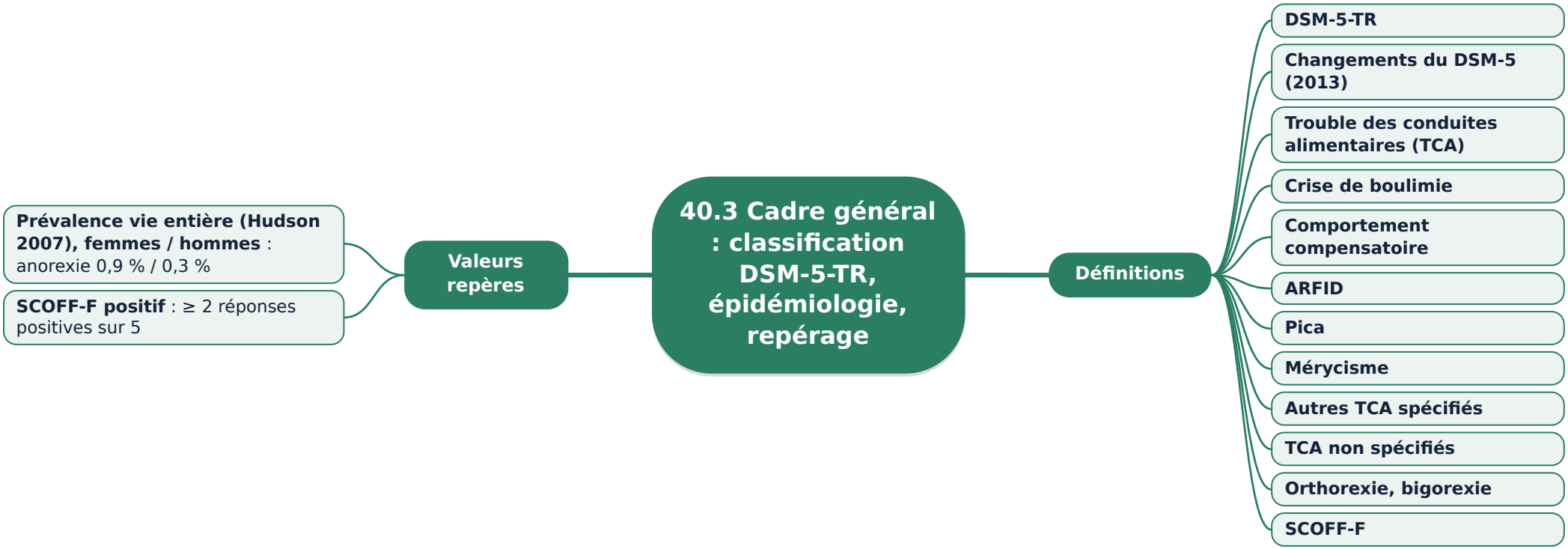
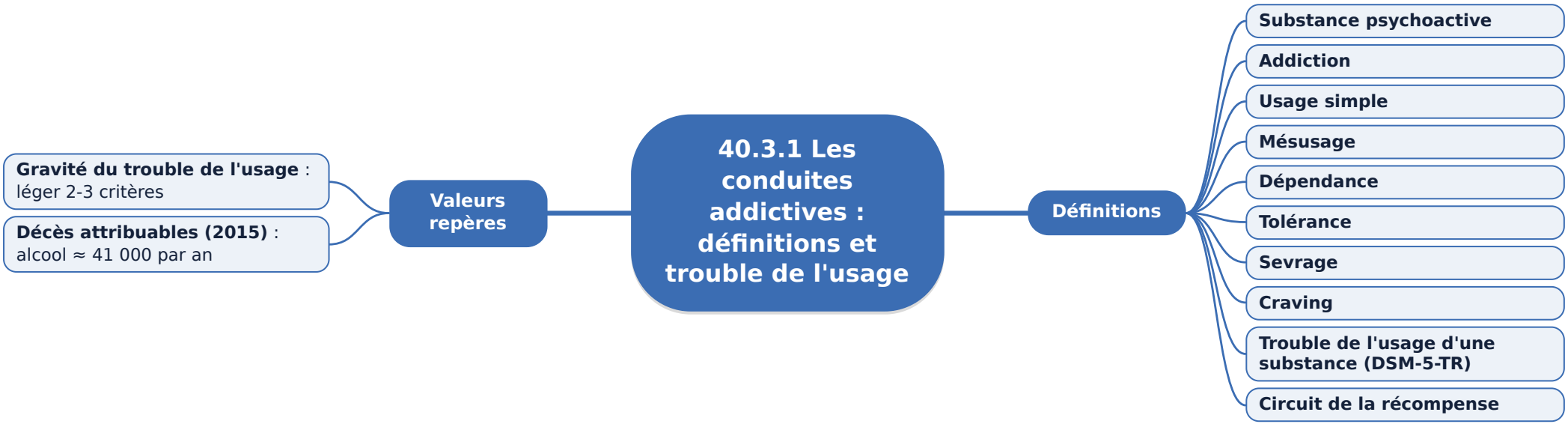
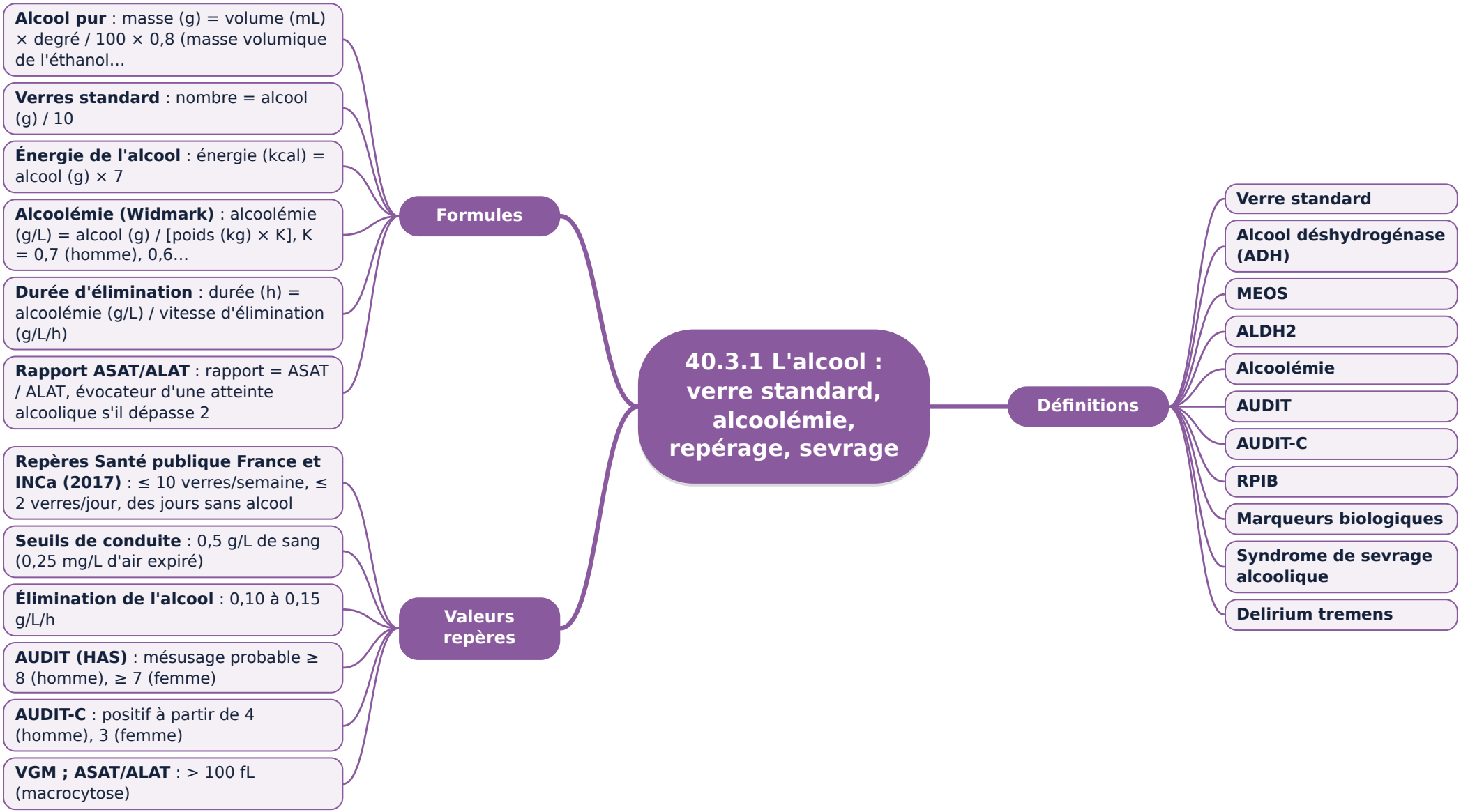
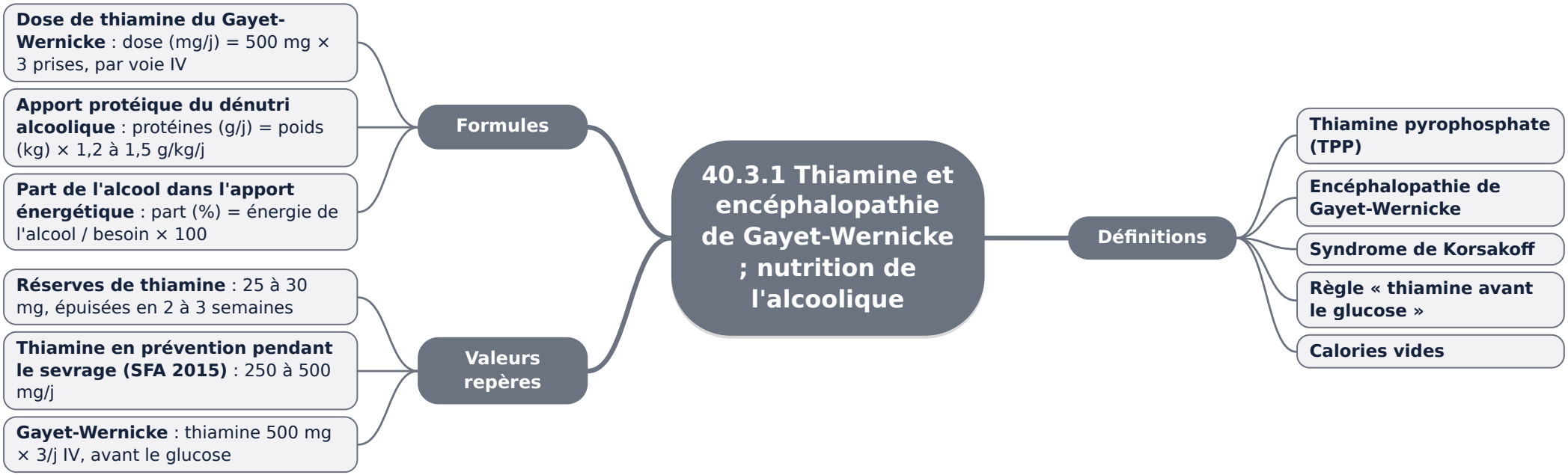
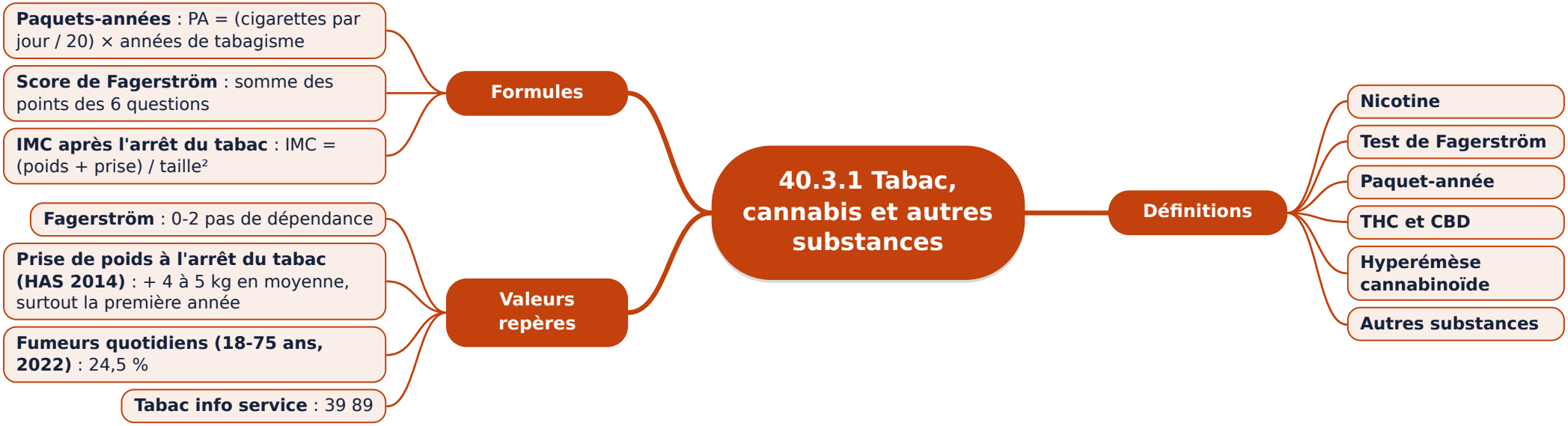

Troubles des conduites alimentaires
40.3 Cadre général : classification DSM-5-TR, épidémiologie, repérage
40.3.1
Les conduites addictives : définitions et trouble de l'usage
40.3.1
L'alcool : verre standard, alcoolémie, repérage, sevrage
40.3.1
Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; nutrition de l'alcoolique
40.3.1
Tabac, cannabis et autres substances
40.3.2
L'anorexie mentale
40.3.3
La boulimie
40.3.4
L'hyperphagie boulimique
40.9 et 40.11 Études de cas : calculs corrigés


40.3 Cadre général : classification DSM-5-TR, épidémiologie, repérage
Définitions
DSM-5-TR
Changements du DSM-5 (2013)
Trouble des conduites alimentaires (TCA)
Crise de boulimie
Comportement compensatoire
ARFID
Pica
Mérycisme
Autres TCA spécifiés
TCA non spécifiés
Orthorexie, bigorexie
SCOFF-F
Valeurs repères
Prévalence vie entière (Hudson 2007), femmes / hommes : anorexie 0,9 % / 0,3 %
SCOFF-F positif : ≥ 2 réponses positives sur 5


40.3.1 Les conduites addictives : définitions et trouble de l'usage
Définitions
Substance psychoactive
Addiction
Usage simple
Mésusage
Dépendance
Tolérance
Sevrage
Craving
Trouble de l'usage d'une substance (DSM-5-TR)
Circuit de la récompense
Valeurs repères
Gravité du trouble de l'usage : léger 2-3 critères
Décès attribuables (2015) : alcool ≈ 41 000 par an


40.3.1 L'alcool : verre standard, alcoolémie, repérage, sevrage
Définitions
Verre standard
Alcool déshydrogénase (ADH)
MEOS
ALDH2
Alcoolémie
AUDIT
AUDIT-C
RPIB
Marqueurs biologiques
Syndrome de sevrage alcoolique
Delirium tremens
Formules
Alcool pur : masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8 (masse volumique de l'éthanol...
Verres standard : nombre = alcool (g) / 10
Énergie de l'alcool : énergie (kcal) = alcool (g) × 7
Alcoolémie (Widmark) : alcoolémie (g/L) = alcool (g) / [poids (kg) × K], K = 0,7 (homme), 0,6...
Durée d'élimination : durée (h) = alcoolémie (g/L) / vitesse d'élimination (g/L/h)
Rapport ASAT/ALAT : rapport = ASAT / ALAT, évocateur d'une atteinte alcoolique s'il dépasse 2
Valeurs repères
Repères Santé publique France et INCa (2017) : ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2 verres/jour, des jours sans alcool
Seuils de conduite : 0,5 g/L de sang (0,25 mg/L d'air expiré)
Élimination de l'alcool : 0,10 à 0,15 g/L/h
AUDIT (HAS) : mésusage probable ≥ 8 (homme), ≥ 7 (femme)
AUDIT-C : positif à partir de 4 (homme), 3 (femme)
VGM ; ASAT/ALAT : > 100 fL (macrocytose)


40.3.1 Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; nutrition de l'alcoolique
Définitions
Thiamine pyrophosphate (TPP)
Encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Syndrome de Korsakoff
Règle « thiamine avant le glucose »
Calories vides
Formules
Dose de thiamine du Gayet-Wernicke : dose (mg/j) = 500 mg × 3 prises, par voie IV
Apport protéique du dénutri alcoolique : protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j
Part de l'alcool dans l'apport énergétique : part (%) = énergie de l'alcool / besoin × 100
Valeurs repères
Réserves de thiamine : 25 à 30 mg, épuisées en 2 à 3 semaines
Thiamine en prévention pendant le sevrage (SFA 2015) : 250 à 500 mg/j
Gayet-Wernicke : thiamine 500 mg × 3/j IV, avant le glucose


40.3.1 Tabac, cannabis et autres substances
Définitions
Nicotine
Test de Fagerström
Paquet-année
THC et CBD
Hyperémèse cannabinoïde
Autres substances
Formules
Paquets-années : PA = (cigarettes par jour / 20) × années de tabagisme
Score de Fagerström : somme des points des 6 questions
IMC après l'arrêt du tabac : IMC = (poids + prise) / taille²
Valeurs repères
Fagerström : 0-2 pas de dépendance
Prise de poids à l'arrêt du tabac (HAS 2014) : + 4 à 5 kg en moyenne, surtout la première année
Fumeurs quotidiens (18-75 ans, 2022) : 24,5 %
Tabac info service : 39 89

40.3.2 L'anorexie mentale

Définitions

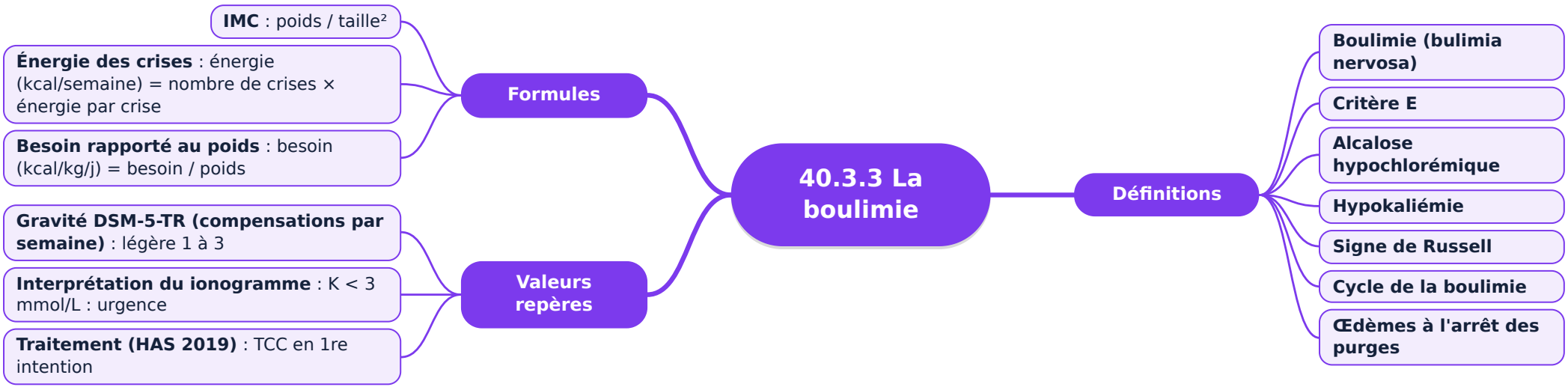
- **Anorexie mentale**
- **Critères DSM-5-TR**
- **Type restrictif**
- **Type avec crises de boulimie et purges**
- **Syndrome de basse T3**
- **Hypogonadisme hypogonadotrope**
- **Lanugo, acrocyanose**
- **Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)**
- **Repas thérapeutique**

Valeurs repères

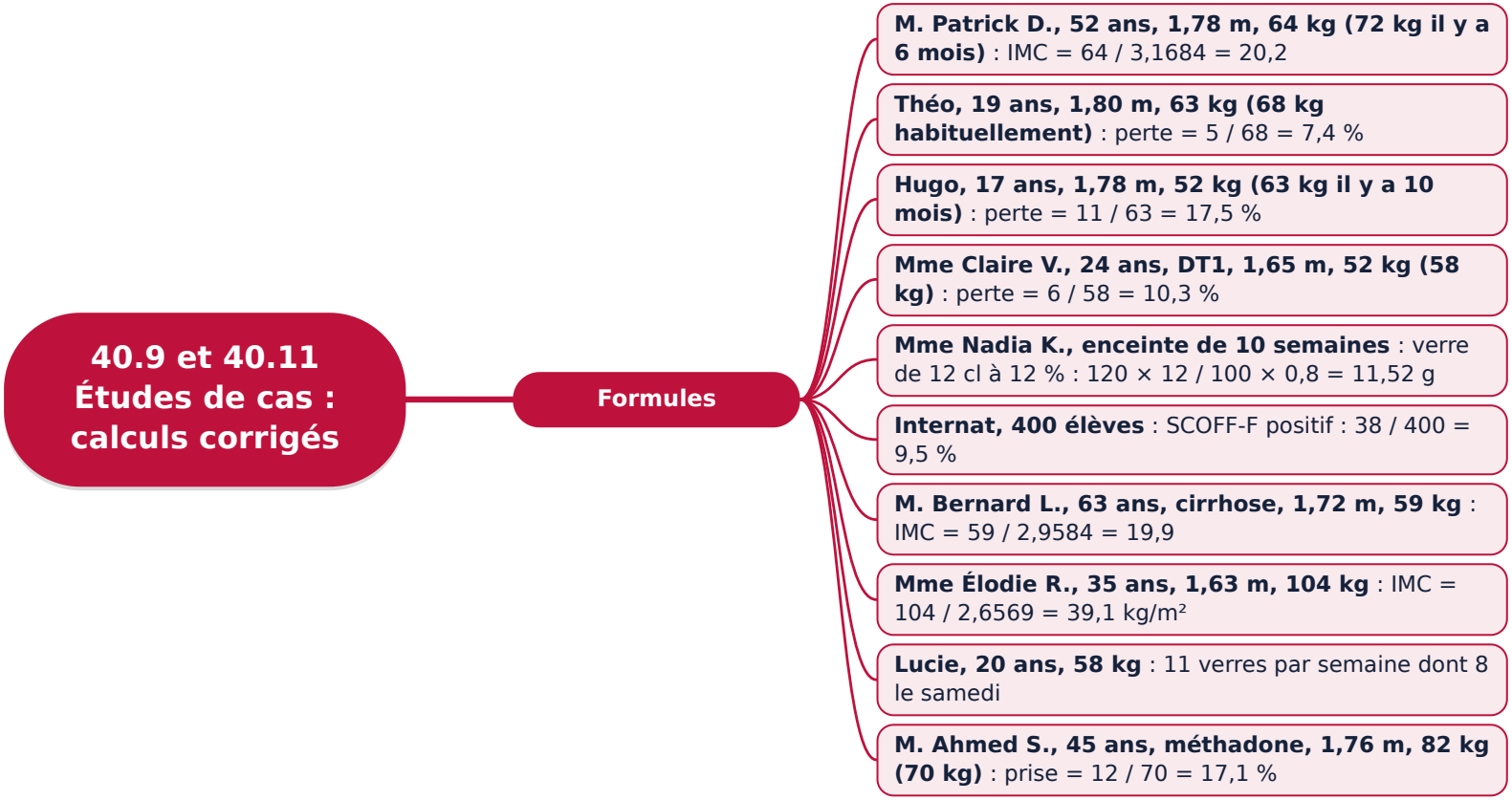
- **Gravité DSM-5-TR (adulte, IMC kg/m²)** : légère ≥ 17
- **Épidémiologie** : début 14 à 17 ans
- **Hospitalisation HAS 2010, adulte** : IMC < 14
- **Hospitalisation HAS 2010, adolescent** : IMC < 14 après 17 ans, < 13,2 à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14…
- **Vitesse de reprise (HAS 2010)** : 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital
- **Risque de SRI (NICE 2006)** : IMC < 16
- **Énergie de la reprise** : ≈ 7 000 kcal par kg de poids repris
- **Structure des repas ; calcium (ANSES 2021)** : 3 repas et 1 à 3 collations

Formules

- **IMC** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Poids pour un IMC cible** : poids cible (kg) = IMC cible × taille²
- **Durée de reprise** : durée (semaines) = poids à reprendre / vitesse de reprise (kg/semaine)
- **Surplus énergétique de la reprise** : surplus (kcal/j) = vitesse (kg/semaine) × 7 000 / 7


40.3.3 La boulimie
Définitions
Boulimie (bulimia nervosa)
Critère E
Alcalose hypochlorémique
Hypokaliémie
Signe de Russell
Cycle de la boulimie
Œdèmes à l'arrêt des purges
Formules
IMC : poids / taille²
Énergie des crises : énergie (kcal/semaine) = nombre de crises × énergie par crise
Besoin rapporté au poids : besoin (kcal/kg/j) = besoin / poids
Valeurs repères
Gravité DSM-5-TR (compensations par semaine) : légère 1 à 3
Interprétation du ionogramme : K < 3 mmol/L : urgence
Traitement (HAS 2019) : TCC en 1re intention


40.3.4 L'hyperphagie boulimique
Définitions
Hyperphagie boulimique (binge eating disorder)
Caractéristiques des crises (≥ 3 sur 5)
Formules
IMC : poids / taille²
Objectif de perte de poids : perte (kg) = poids × 5 à 10 %
Valeurs repères
Gravité DSM-5-TR (crises par semaine) : légère 1 à 3
Fréquence minimale : au moins 1 crise par semaine pendant 3 mois
Lien avec l'obésité : 20 à 30 % des personnes qui consultent pour une obésité


40.9 et 40.11 Études de cas : calculs corrigés
Formules
M. Patrick D., 52 ans, 1,78 m, 64 kg (72 kg il y a 6 mois) : IMC = 64 / 3,1684 = 20,2
Théo, 19 ans, 1,80 m, 63 kg (68 kg habituellement) : perte = 5 / 68 = 7,4 %
Hugo, 17 ans, 1,78 m, 52 kg (63 kg il y a 10 mois) : perte = 11 / 63 = 17,5 %
Mme Claire V., 24 ans, DT1, 1,65 m, 52 kg (58 kg) : perte = 6 / 58 = 10,3 %
Mme Nadia K., enceinte de 10 semaines : verre de 12 cl à 12 % : 120 × 12 / 100 × 0,8 = 11,52 g
Internat, 400 élèves : SCOFF-F positif : 38 / 400 = 9,5 %
M. Bernard L., 63 ans, cirrhose, 1,72 m, 59 kg : IMC = 59 / 2,9584 = 19,9
Mme Élodie R., 35 ans, 1,63 m, 104 kg : IMC = 104 / 2,6569 = 39,1 kg/m²
Lucie, 20 ans, 58 kg : 11 verres par semaine dont 8 le samedi
M. Ahmed S., 45 ans, méthadone, 1,76 m, 82 kg (70 kg) : prise = 12 / 70 = 17,1 %

Les pièges

- « Chez un alcoolique dénutri, on perfuse d'abord du glucose, puis on donne la thiamine le lendemain. » → faux : La thiamine doit être donnée avant ou avec le glucose, sinon on risque de déclencher un Gayet-Wernicke.
- « La triade confusion, ataxie, troubles oculomoteurs est presque toujours complète dans le Gayet-Wernicke. » → faux : Elle est complète dans moins d'un cas sur cinq : on traite au moindre doute.
- « Un score de Fagerström de 3 indique une dépendance forte. » → faux : 3-4 : dépendance faible ; forte à partir de 7.
- « La leptine est élevée dans l'anorexie mentale. » → faux : Elle s'effondre avec la masse grasse, ce qui freine l'axe gonadotrope.
- « Le syndrome de basse T3 de l'anorexie doit être traité par des hormones thyroïdiennes. » → faux : C'est une adaptation d'économie ; il se corrige avec la renutrition.
- « Dans l'hyperphagie boulimique, il faut commencer par un régime hypocalorique strict. » → faux : La restriction aggrave les crises : on traite les crises d'abord.
- « L'aménorrhée est un critère obligatoire du diagnostic d'anorexie mentale. » → faux : Elle a été retirée des critères depuis le DSM-5 (2013), même si elle est fréquente.
- « Dans l'anorexie mentale, la sensation de faim disparaît. » → faux : La faim existe (ghréline élevée) mais elle est niée et combattue.
- « L'hyperphagie boulimique comporte des vomissements provoqués réguliers. » → faux : Elle se définit par l'absence de compensations régulières.
- « Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. » → faux : Ils provoquent une alcalose hypochlorémique (perte d'HCl) ; ce sont les laxatifs qui provoquent une acidose.
- « Les laxatifs empêchent l'absorption des calories d'une crise. » → faux : L'absorption a lieu dans l'intestin grêle ; les laxatifs agissent sur le côlon et font perdre surtout de l'eau et des électrolytes.
- « Les repères de 2017 autorisent 3 verres par jour pour les hommes. » → faux : Le repère est le même pour tous : 2 verres par jour au maximum, 10 par semaine, pas tous les jours.